



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : هاله خميس اتمانى قلدس
المحافظة : الجيزة الحي / المدينة : الجيزة
رقم البطاقة : 27008130103149 رقم التليفون : 01271066797
العنوان : 0
العمر (تاريخ الميلاد) : 13-08-1970 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 29-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالعظام
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالعظام
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6421] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هاله خميس اتمانى قلدس National ID: 27008130103149	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

A patient of bone cancer for Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

هاله
خميس اتماني قلّس
١ ش عفيفي عبدالله
الجيزة - الجيزة

١٩٧٠ / ١٠ / ٣
٢٧٠٠٨١٣٠١٠٣١٤٩

KN3300249





Pat. Name Mrs. Hala Khamis Atmani Kaldas	Pat. ID: 193725
Ref. Doctor: د/علاء طريف	Date : 26/09/2026

REPORT

I- MRI EXAMINATION OF THE CERVICAL SPINE

TECHNIQUE:-

- Sagittal T1 and T2 WIs.
- Axial T1 and T2 WIs.
- No contrast was given.

MR FINDINGS:-

- Preserved cervical lordosis.
- Normal dimensions of the bony cervical spinal canal.
- Spondylodegenerative changes of cervical spine evidenced by reduced height and loss of normal bright T2 signal of intervertebral discs as well as marginal osteophytic lipping of vertebral endplates.
- C3/4 and C4/5 posterior central focal disc protrusions abutting the cord.
- C5/6 mild diffuse posterior disc bulge is seen effacing the anterior subarachnoid space and abutting the ventral aspect of the cord as well as slightly encroaching upon both neural exit foramina.
- Normal size, shape and signal intensity pattern of the cervical spinal cord and cranio-cervical junction. No evidence of cord atrophy, malacia or syrinx formation.
- Signal marrow alteration of C5 and C7 vertebral bodies eliciting bright STIR signal as well as low T1 signal.
- No gross peri-spinal soft tissue abnormality could be detected.

OPINION:

- ✚ *Spondylodegenerative changes of Cervical spine showing multilevel disc lesions as described above, for clinical correlation.*
- ✚ *Signal marrow alteration of C5 and C7 vertebral bodies denoting malignant infiltrative marrow lesion, likely metastatic deposits for further evaluation.*



Pat. Name Mrs. Hala Khamis Atmani Kaldas	Pat. ID: 193725
Ref. Doctor: د/عادل ظريف	Date : 26/09/2026

II-MRI EXAMINATION OF THE DORSAL SPINE REVEALED

Technique:-

- Sagittal T1 and T2 WIs
- Axial T1 and T2 WIs

Findings:-

- Central compression fracture with markedly reduced height of D3 vertebral body seen encroaching upon the subarachnoid space and compressing the spinal cord with related marrow edema.
- Patchy signal arrow alteration of D2, D4, D5, D7, D8 and D11 vertebral bodies, eliciting bright STIR signal as well as low T1 signal.
- Good alignment of the dorsal spine.
- Normal dimensions of the bony dorsal spinal canal.
- Preserved height and T2 signal intensity of the scanned dorsal inter-vertebral discs.
- No significant discal lesions or neural compromise are detected.
- Normal MR appearance of the dorsal spinal cord.
- Intact apophyseal joints with preserved neural exit canals.
- No gross peri-spinal soft tissue abnormality is detected.

Conclusion:

- ✦ *Central compression fracture with markedly reduced height of D3 vertebral body seen encroaching upon the subarachnoid space and compressing the spinal cord with related marrow edema.*
- ✦ *Patchy signal marrow alteration of D2, D4, D5, D7, D8 and D11 vertebral bodies.*
- ✦ *For bone scan correlation.*



Pat. Name Mrs. Hala Khamis Atmani Kaldas	Pat. ID: 193725
Ref. Doctor: د/علاء طريف	Date : 26/09/2026

III-NON CONTRAST MRI EXAMINATION OF THE LUMBAR SPINE

REVEALED

Technique:-

- Sagittal T1 and T2 WIs
- Axial T1 and T2 WIs
- No Contrast was given.

Findings:-

- Diffuse non homogenous marrow signal intensity pattern of the lumbo-sacral spine showing predominant patchy hypointensity T1 signal & heterogenous bright T2 /STIR signal suggestive of infiltrative marrow lesion with metastatic deposit, for further evaluation and bone scan.
- Minimal ventral wedging of L1 vertebral body shows similar heterogenous marrow infiltration.
- Preserved lumbar lordosis.
- Normal dimensions of the bony lumbar spinal canal.
- Preserved height and T2 signal intensity of the lumbar inter-vertebral discs.
- L3/4 and L4/5 mild bi-postero-lateral discs bulge are seen effacing the anterior epidural fat, abutting the theca and minimally encroaching upon both neural exit foramina augmented by relatively hypertrophied ligamenta flava posteriorly, their significance should be clinically correlated.
- Normal MR appearance of the conus medullaris and cauda roots.
- Intact apophyseal joints.
- No gross peri-spinal soft tissue abnormality is detected.

Best Regards,

Dr. George Ayad M.D